

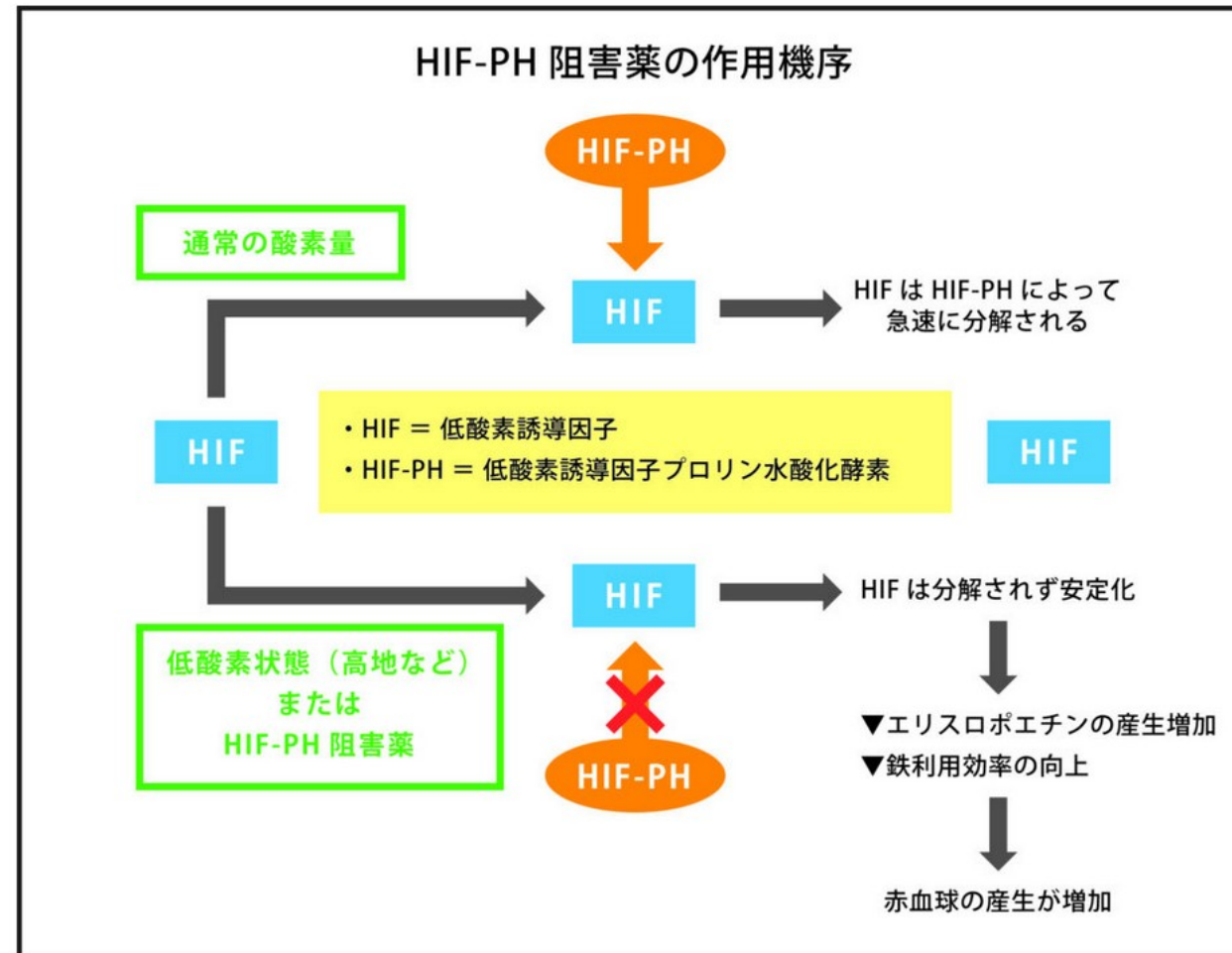
A剤

B剤

A剤

商品名	メーカー (単位)									
		Na	K	Ca	Mg	Cl	HCO3-	酢酸	Glu	クエン酸
		(mEq/L)							(mg/dL)	(mEq/L)
Dドライ透析剤3.0S	日機装	140	2.0	3.0	1.0	113	25	10	100	-
キンダリー透析剤AF2号	扶桑薬品	140	2.0	3.0	1.0	110	30	8	100	-
キンダリー透析剤AF5号	工業	140	2.3	2.6	1.2	113.9	30	4.2	150	-
カーボスター透析剤L	陽進堂	140	2.0	3.0	1.0	110	35	0	150	2.0
透析患者の基準値		136~145	3.5~6.0	8.4~10.0 (mg/dL) 2.1~2.5 (mEq/L)	1.8~2.4 (mg/dL) 1.5~2.0 (mEq/L)	98~ 108	20~25		180~ 200 (DM 患者)	

3 エリスロポエチンと低酸素誘導因子



エリスロポエチンは体内の酸素濃度が低下しても分泌されることが知られています。この反応を制御する物質が発見され、HIF（低酸素誘導因子）と名付けられました。体内に酸素が十分あるときにはこの物質は分解酵素（HIF-PH）により速やかに分解されますが、この酵素を阻害する薬剤を投与することにより、体内の酸素量が保たれている状態でもエリスロポエチンの産生が促進されることが分かりました。

CKD-MBD（の省略版）

透析患者の血液

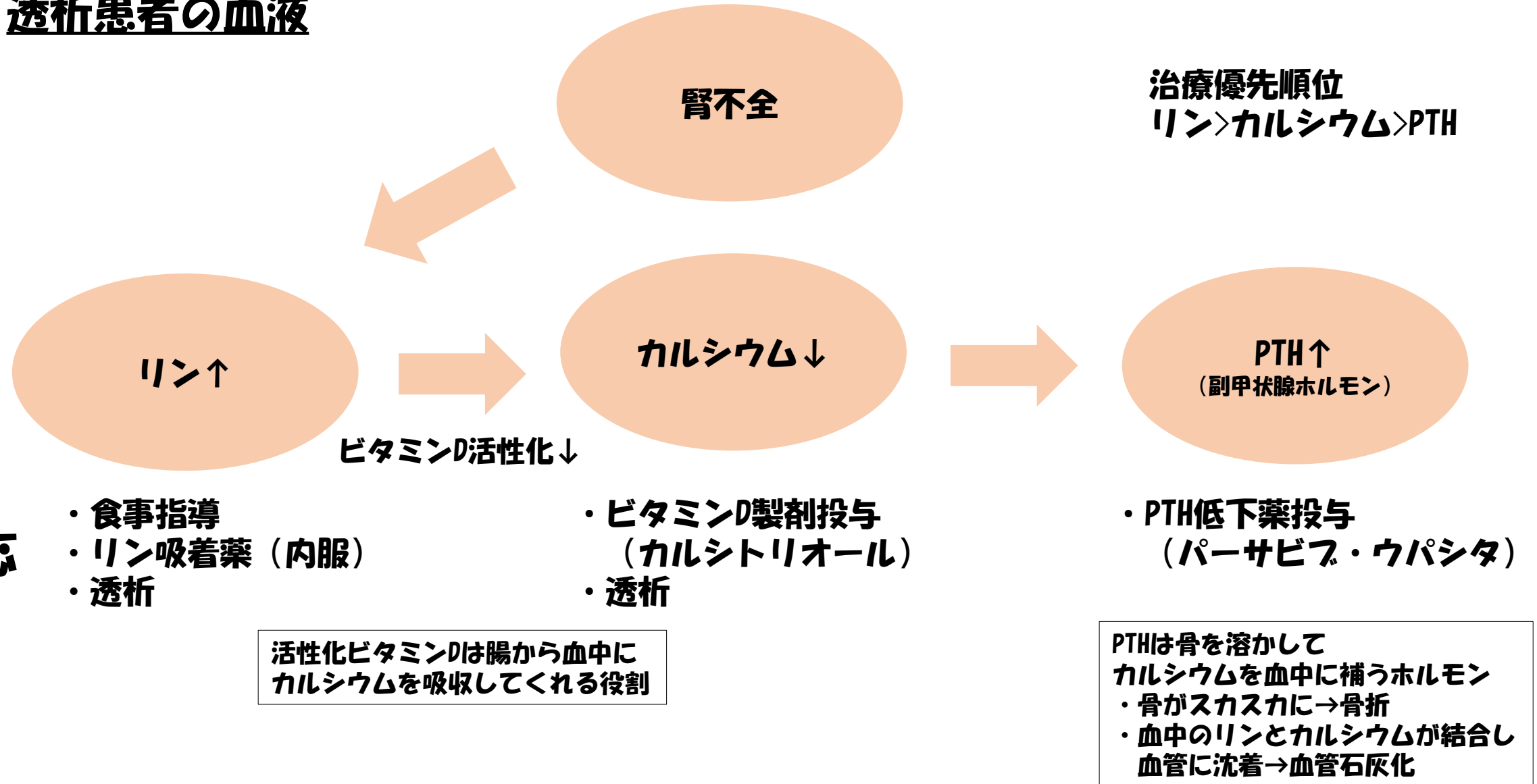
対応

- ・ 食事指導
- ・ リン吸着薬（内服）
- ・ 透析

活性化ビタミンDは腸から血中に
カルシウムを吸収してくれる役割

- ・ ビタミンD製剤投与
（カルシトリオール）
- ・ 透析

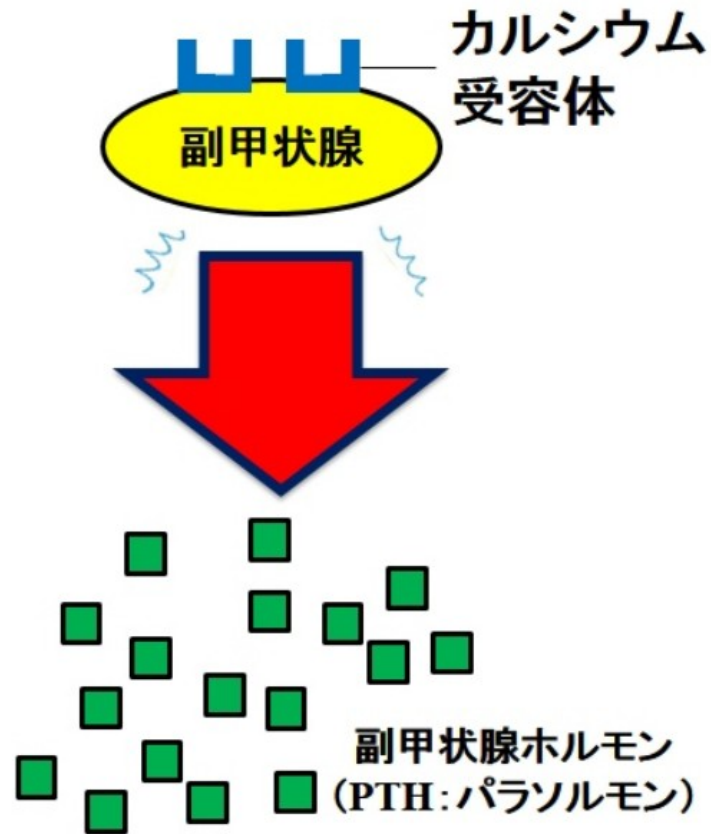
治療優先順位
リン>カルシウム>PTH



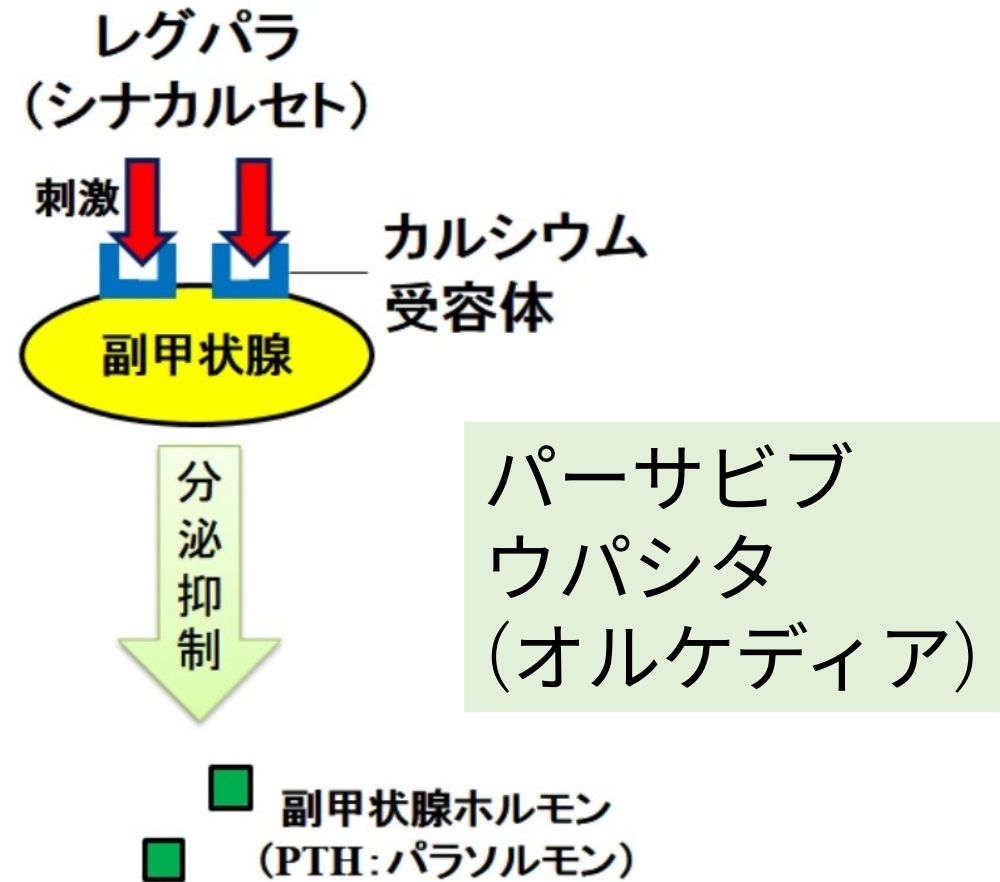
- ・ PTH低下薬投与
（パーサビフ・ウパシタ）

PTHは骨を溶かして
カルシウムを血中に補うホルモン
・ 骨がスカスカに→骨折
・ 血中のリンとカルシウムが結合し
血管に沈着→血管石灰化

■ カルシウム



慢性腎不全では、
低カルシウム血症・高リン血症により、
PTHの分泌が過剰になる
⇒副甲状腺機能亢進症



レグパラがカルシウム受容体を刺激することで、PTHの過剰分泌を抑制する

エポエチン750～9000/週 < ダルベポエチン60/週 < ミルセラ100～200/月